

กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

กรอบยุทธศาสตร์

ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ. 2569-2572

มีนาคม 2569

กรอบยุทธศาสตร์
ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน
และหัดเยอรมันแต่กำเนิด
ประเทศไทย
พ.ศ. 2569 – 2572

Strategic Framework for Measles, Rubella and Congenital Rubella Syndrome Elimination in Thailand, 2026 – 2029

กองโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ. 2569 – 2572

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์	ประธานคณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ตามพันธสัญญานานาชาติ
นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท	คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร	ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

คณะผู้เรียบเรียง

บทที่ 1	นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย	คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
	นางมนัญญา ประเสริฐสุข	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
บทที่ 2	แพทย์หญิงภาวินี ด้วงเงิน	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นางสาวปรางณพิชญ์ วิหารทอง	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นางสาวปณิตา คุ้มผล	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นางสาวศริญญา ไชยยา	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นายฉัตรมงคล ส้มแป้น	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นายภูมิภัทร ยอดชมภู	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นางมนัญญา ประเสริฐสุข	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
บทที่ 3	นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย	คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
	นางมนัญญา ประเสริฐสุข	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
	แพทย์หญิงภาวินี ด้วงเงิน	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นางอัจฉริยา ลูกบัว	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทที่ 4	นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย	คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
	แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
	แพทย์หญิงปิติภรณ์ พรมดวงสี	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
	นางมนัญญา ประเสริฐสุข	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
	แพทย์หญิงภาวินี ด้วงเงิน	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	แพทย์หญิงชรัฐพร จิตพีระ	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นายแพทย์พิริยะ วตะกูลสิน	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	นางอัจฉริยา ลูกบัว	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	นายประสพชัย อร่ามรุ่งโรจน์	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	นางสาวกรรณิการ์ ขวัญชุม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทที่ 5	นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย	คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
	นางมนัญญา ประเสริฐสุข	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการ

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย	คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดแห่งชาติ
แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางมนัญญา ประเสริฐสุข	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำนำ

ประเทศไทยได้ให้ข้อตกลงกับนานาประเทศในการร่วมกันกำจัดกวาดล้างโรคหัดและหัดเยอรมันให้หมดไป โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และกำหนดเป้าหมายการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ภายในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย มีการขับเคลื่อนมาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาด รวมถึงพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย ปี 2020 – 2024 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ทั่วโลกในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2566 ส่งผลกระทบต่อระบบเฝ้าระวังและการให้บริการวัคซีนของประเทศไทย ประชาชนบางกลุ่มยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเกิดความลังเลในการรับวัคซีน ประกอบกับยังมีช่องว่างของภูมิคุ้มกันในประชากรบางกลุ่มอายุ ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2567 ที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคหัดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับ องค์การอนามัยโลก ได้เลื่อนเป้าหมายการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน จากปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2566 และล่าสุดเลื่อนเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันเป็นภายในปี พ.ศ. 2569

ดังนั้น จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ. 2569 – 2572 ขึ้น โดยปรับปรุงมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคหัดและหัดเยอรมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคตามพันธสัญญานานาชาติ

สารบัญ

คำนำ	**4**
สารบัญ	**5**
บทที่ 1 บทนำ	**6**
บทที่ 2 สถานการณ์ และการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหัด และหัดเยอรมัน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 - 2567	**8**
บทที่ 3 ประเด็นสำคัญ ความท้าทาย และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา	**11**
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของกรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ. 2569 – 2572	**20**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในทุกกลุ่มประชากร ให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาด	**22**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรค และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ	**24**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	**26**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมรับมือและการตอบโต้การระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน	**28**
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน อย่างยั่งยืน	**29**
บทที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล	**30**
บรรณานุกรม	**32**
ภาคผนวก	**33**

บทที่ 1

บทนำ

โรคหัด (Measles) และโรคหัดเยอรมัน (Rubella) เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มีความสามารถในการแพร่กระจายสูงมาก โดยเฉพาะโรคหัดเคยเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในเด็กทั่วโลกก่อนที่จะมีการนำวัคซีนป้องกันโรคหัดมาใช้ในปี พ.ศ. 2506 โดยมีข้อมูลว่า เคยพบการระบาดใหญ่ของโรคหัดเกิดขึ้นทุก 2-3 ปี ในช่วงหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยโรคหัดสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันยังคงพบการระบาดของโรคหัดอยู่เป็นระยะในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรคหัดเยอรมัน ยังคงเป็นโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การแท้งบุตร การเสียชีวิตของทารกในครรภ์ หรือการเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome; CRS) ส่งผลให้ทารกมีความพิการถาวร เช่น หูหนวก ตาบอด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และพัฒนาการล่าช้า ภาระจากหัดเยอรมันแต่กำเนิด สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว รวมทั้งสร้างภาระระยะยาวต่อระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม

อย่างไรก็ตาม ได้มีการคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยวัคซีนสามารถป้องกันโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่าในช่วงกว่า 50 ปีที่ผ่านมา วัคซีนป้องกันโรคหัดได้ช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกนับร้อยล้านราย สำหรับในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออกเพียงแห่งเดียว การฉีดวัคซีนสามารถลดการเสียชีวิตของประชากรได้กว่า 20 ล้านราย ซึ่งหากสามารถฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมสูงและสม่ำเสมอ จะสามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อ และนำไปสู่การกำจัดโรคหัดได้อย่างแท้จริง

เมื่อพิจารณาจากความรุนแรงของโรคและประสิทธิภาพของวัคซีน องค์การอนามัยโลกจึงได้หารือร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อผลักดันการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ค.ศ. 2030 อีกทั้งเป็นการสะท้อนฉันทามติของประชาคมโลกว่าการกำจัดโรคหัดเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเข้มแข็งระบบสาธารณสุข โดยในระยะแรกได้กำหนดให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่เนื่องจากยังพบสถานการณ์การระบาดของโรค ประกอบกับผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 องค์การอนามัยโลก จึงได้พิจารณาเลื่อนกำหนดการบรรลุเป้าหมายไปยังปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) และล่าสุดได้ปรับเป้าหมายเป็นปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ได้ดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเฝ้าระวังโรค การตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และการตอบโต้การระบาด และได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรค

หัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย ปี 2020 – 2024 อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมจะมีความก้าวหน้า แต่อัตราความครอบคลุมวัคซีนยังไม่ถึงระดับที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในทุกพื้นที่ อาทิ พื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ชายแดน หรือในกลุ่มประชากรกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งยังพบข้อจำกัดของระบบเฝ้าระวัง และการตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันได้ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับยุทธศาสตร์การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้ทบทวนแนวทางจากกรอบยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก 2024–2028 (Strategic Plan for measles and rubella elimination and sustenance in the WHO South-East Asia Region: 2024-2028) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ ภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ไม่พบการติดเชื้อไวรัสหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด สายพันธุ์ท้องถิ่น ภายในแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) และมุ่งหวังให้แต่ละประเทศ ได้รับการยืนยันการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด จากคณะกรรมการตรวจสอบระดับภูมิภาค (Regional Verification Commission - RVC) ขององค์การอนามัยโลก ภายในปี พ.ศ. 2572 (ค.ศ. 2029) โดยได้เน้นมาตรการสำคัญเพื่อให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคฯ ได้พิจารณาดำเนินการ ได้แก่

1. เพิ่มและรักษาความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน (MRCV) ทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในทุกพื้นที่
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาด อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์
3. พัฒนาเครือข่ายการตรวจเชื้อหัดและหัดเยอรมันทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วประเทศ
4. เสริมสร้างความเข็มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค และการตอบโต้การระบาดของโรคหัดอย่างทันท่วงที
5. เชื่อมโยงกับแผนงานสาธารณสุขอื่นๆ เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ทั้ง 4 ประการข้างต้น

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย จึงได้นำกรอบแนวคิด และข้อเสนอแนะจากแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค มาทบทวน วิเคราะห์ และประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยกรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ. 2569 – 2572 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานทุกระดับ ในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

บทที่ 2 สถานการณ์ และการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหัด หัดเยอรมัน และ หัดเยอรมันแต่กำเนิด ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2567

ช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคหัดครั้งใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก สถานการณ์โรคหัดทั่วโลก เกือบ 41 ประเทศได้ยุติการรณรงค์การให้วัคซีนโรคหัดในปี พ.ศ. 2563 และอาจยุติการรณรงค์จนถึงปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถานการณ์โรคหัด ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยหัดและหัดเยอรมัน ทั้งสิ้น 1,906 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันหัดทางห้องปฏิบัติการ 337 ราย และผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 111 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.67 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันหัดทางห้องปฏิบัติการ และผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา พบอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุน้อยกว่า 1 ปี (12.46 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 1–4 ปี (2.09) อายุ 20–29 ปี (1.71) อายุ 30–39 ปี (0.80) และอายุ 15–19 ปี (0.77) ตามลำดับ เป็นผู้ป่วยสัญชาติไทยร้อยละ 94 อัตราส่วนเพศหญิงต่อชาย เท่ากับ 1:2 จังหวัดที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากรสะสมมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส (12.38 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (6.48) เชียงใหม่ (4.27) สตูล (3.09) และระยอง (2.31) ตามลำดับ จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 84 ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยมีการระบาด 28 เหตุการณ์ จำนวนผู้ป่วยต่อเหตุการณ์อยู่ระหว่าง 2–75 ราย (ค่ามัธยฐาน 3 ราย) พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการระบาดในหมู่บ้านและครอบครัว จำนวน 13 เหตุการณ์ในพื้นที่อื่น ๆ พบการระบาดมากที่สุดในเรือนจำ จำนวน 2 เหตุการณ์ ที่จังหวัดสตูล และอุบลราชธานี

ในปี พ.ศ. 2564 โรคหัดยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยหัดประมาณ 9 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตกว่า 128,000 ราย แม้ว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดี แต่ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในเด็กทั่วโลกลดลงเหลือเพียงร้อยละ 81 ซึ่งถือว่าต่ำและอาจนำไปสู่การระบาดใหญ่ได้ ในปีเดียวกันนี้หลายประเทศยังคงเผชิญกับการระบาดต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2565

สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2564 มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด–หัดเยอรมัน 242 ราย ในจำนวนนี้ 8 รายได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ คิดเป็นอัตราป่วย 0.012 ต่อแสนประชากร โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และมากกว่าครึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน การกระจายของผู้ป่วยพบในบางจังหวัด เช่น ยะลา ระยอง ตรัง เชียงราย และสงขลา โดยไม่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ปี พ.ศ. 2565 สถานการณ์ในประเทศยังคงมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า มีรายงานผู้ป่วยสงสัย 250 ราย และได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 14 ราย อัตราป่วยอยู่ที่ 0.02 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานการเสียชีวิต

ผู้ป่วยพบมากในกลุ่มอายุน้อยกว่า 1 ปี ในจังหวัดยโสธร ชัยนาท ระยอง แพร่ และสมุทรสาคร จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ป่วยกว่าร้อยละ 40 ไม่เคยหรือไม่แน่ใจว่าได้รับวัคซีนมาก่อน

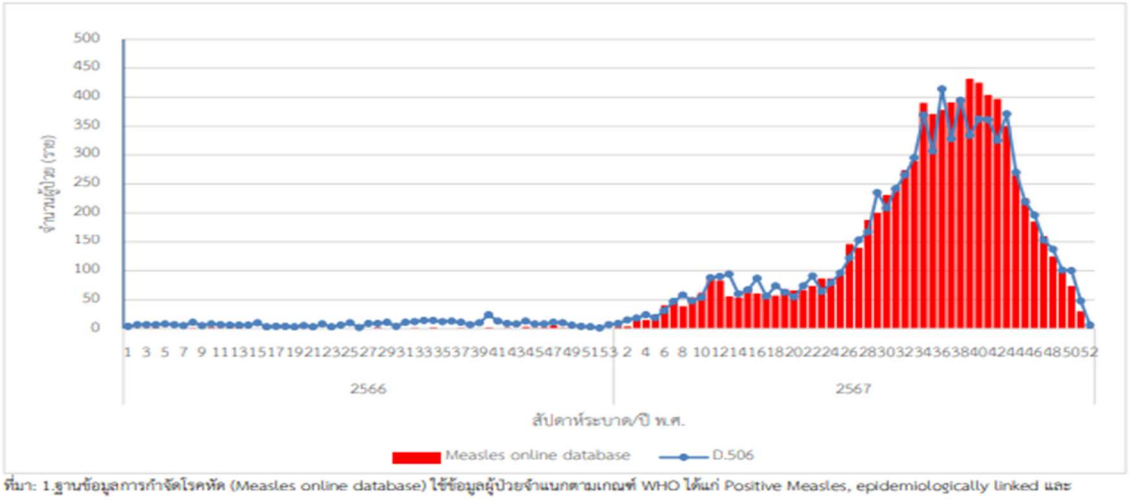
ปี พ.ศ. 2566 หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การรายงานผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยองค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยกว่า 400,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้–ตะวันออก ที่พบผู้ป่วยยืนยันมากที่สุด ความครอบคลุมของวัคซีนทั่วโลกลดลงเหลือเพียงร้อยละ 83 ต่ำที่สุดในรอบกว่า 15 ปี

ประเทศไทยในปีเดียวกันมีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยหัด–หัดเยอรมัน 677 ราย และยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 18 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในจังหวัดตราด ยโสธร อำนาจเจริญ สกลนคร และลำปาง ผู้ป่วยกว่าครึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

สำหรับสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2567 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยประเทศไทยรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด หัดเยอรมันถึง 10,446 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 4,288 ราย และมีผู้ป่วยที่มีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาอีก 1,030 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.05 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าช่วงสามปีก่อนหน้าอย่างมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และมากถึงร้อยละ 71 ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ำ

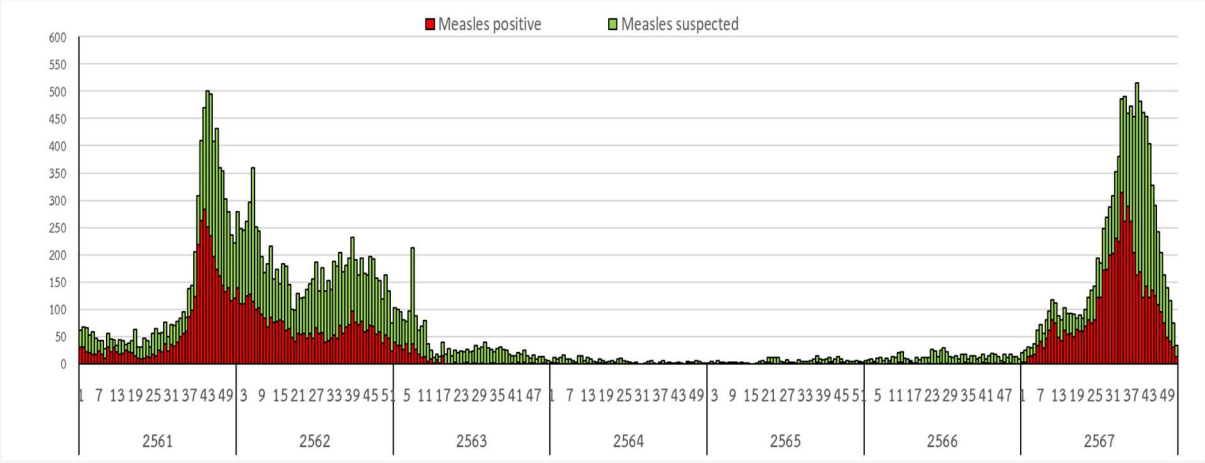
เมื่อพิจารณาภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563–2567 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในระดับต่ำต่อเนื่องมาหลายปี แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2567 สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างด้านภูมิคุ้มกันในประชากรเด็กเล็กและความครอบคลุมของวัคซีนที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย โดยจากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) พบว่ามีถึง 73 จังหวัด ที่มีความครอบคลุมของวัคซีน MMR2 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 95 การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2567 จึงเป็นสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันและการเสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคหัด–หัดเยอรมัน เพื่อป้องกันการระบาดใหญ่และคงไว้ซึ่งสถานะการกำจัดโรคหัดของประเทศไทยในระยะยาว

สถานการณ์โรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567 จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผ่านการรายงานในระบบเฝ้าระวังโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด (โปรแกรมโรคกำจัดกวาดล้าง) รหัส 93 ของระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) และระบบข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม รวมทั้งการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ (Sentinel surveillance) ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ใน 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ได้รับรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด สะสม จำนวน 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.35 ต่อประชากรเด็กเกิดมีชีพหมื่นคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 8 : 1 อายุระหว่าง 0 วัน ถึง 10 เดือน มีการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 16 ราย โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด พบผู้ป่วยยืนยันหัดเยอรมันแต่กำเนิด 1 ราย



ที่มา: 1.ฐานข้อมูลการกำจัดโรคหัด (Measles online database) ใช้ข้อมูลผู้ป่วยจำแนกตามเกณฑ์ WHO ได้แก่ Positive Measles, epidemiologically linked และ clinical compatible cases
2. รายงาน 506 (D506)

รูปที่ 1 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหัด จากฐานข้อมูลการกำจัดโรคหัด (Measles online data base) และรายงาน 506 (D506) จำแนกตามวันเริ่มป่วย ตามสัปดาห์การระบาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยหัด จำแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวันเริ่มป่วย ตามสัปดาห์การระบาด ปี พ.ศ. 2561 – 2567

บทที่ 3: ประเด็นสำคัญ ความท้าทาย และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากการทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของภูมิภาคเอเชียใต้–ตะวันออก พ.ศ. 2567–2571 ได้นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำคัญ ความท้าทาย และปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดของประเทศไทย โดยใช้โมเดลก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เชิงระบบที่สะท้อนความเชื่อมโยงของปัจจัยในหลายมิติ การวิเคราะห์ดังกล่าวมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเชิงนโยบายและบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อระบุปัจจัยเชิงสาเหตุสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการกำจัดโรคอย่างเป็นองค์รวม วิเคราะห์ช่องว่างของระบบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถขับเคลื่อนได้จริงในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับเขตสุขภาพ และระดับพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพันธะสัญญานานาชาติขององค์การอนามัยโลก และบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญประเด็นสำคัญและความท้าทายหลายประการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ดังสรุปไว้ในประเด็นต่อไปนี้

1. **ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค**

   ประเด็นปัญหาและความท้าทาย : ระดับภูมิคุ้มกันของประชากรยังไม่เพียงพอและไม่สม่ำเสมอ (เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)

จากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MMR1 และ MMR2) ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับอำเภอ และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ณ ปี พ.ศ. 2567 เข็มที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 87.6 และเข็มที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 86.5

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันต่ำ ได้แก่ ประชากรบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการวัคซีน เช่น ผู้อพยพ ประชากรในชุมชนห่างไกล และประชากรในพื้นที่เข้าถึงยาก รวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาและความสะดวกของผู้ปกครองที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการพาเด็กเข้ารับบริการวัคซีนตามกำหนด

นอกจากนี้ ยังพบปัจจัยด้านทัศนคติและการรับรู้ของประชาชน เช่น ความลังเลในการรับวัคซีน รวมถึงข้อจำกัดของกลไกการกำกับติดตาม และการให้วัคซีนเสริมแก่ผู้ที่พลาดการรับวัคซีนตามเกณฑ์ ขณะเดียวกัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประชากรเขตเมืองยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ จากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และยากต่อการติดตามให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน ปัญหาด้านคุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูลวัคซีน รวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมการให้วัคซีนในรูปแบบการรณรงค์ (Supplementary Immunization Activities: SIA) ที่ยังไม่สามารถปิดช่องว่างของภูมิคุ้มกันได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ช่องว่างของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสะสม และขยาย

ไปสู่ประชากรวัยรุ่นและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเกิดการระบาดของโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา

การดำเนินงานของประเทศไทย

ประเทศไทยได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยเริ่มจากวัคซีนหัดชนิดเดี่ยว ในเด็กอายุ 9–12 เดือน ต่อมาได้เพิ่มการให้วัคซีนเข็มที่ 2 ในปี พ.ศ. 2539 และปรับเป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในปี พ.ศ. 2540 และขยายเป็นวัคซีนรวมทั้งสองเข็ม ในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้มีการปรับอายุการให้วัคซีนเข็มที่ 2 จากเด็กอายุ 7 ปี เป็น 2 ปี 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และประเทศไทยยังได้ดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนในเด็กอายุ 1–12 ปีทั่วประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2562–2563 และขยายการรณรงค์ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ดำเนินมาตรการเร่งรัดเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน อย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญทั้งในระดับนโยบาย การกำกับติดตาม และการปฏิบัติระดับพื้นที่ มาตรการสำคัญที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวัคซีน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในทุกระดับอย่างใกล้ชิด โดยการผลักดันให้ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เป็นตัวชี้วัดกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และการใช้กลไกการกำกับติดตาม ผ่านการรายงานผลเป็นรายไตรมาส เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการดำเนินงานของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานด้านแรงงาน ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กตกหล่น เด็กต่างชาติ และประชากรเคลื่อนย้าย

สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายเฉพาะด้าน ทั้งในบริบททางสังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ และการเคลื่อนย้ายประชากร โดยได้เข้าพบผู้แทนจุฬาราชมนตรี เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อวัคซีน ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกและเข้มข้นเป็นพิเศษ เช่น การจัดสรรและกระจายวัคซีนเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการของพื้นที่ การสนับสนุนทีมปฏิบัติการ จากส่วนกลางและระดับเขตสุขภาพลงพื้นที่ เพื่อการติดตาม และแก้ไขปัญหาเชิงระบบ รวมถึงการจัดหน่วยให้บริการวัคซีนเชิงรุกในชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพื้นที่เสี่ยง และยังได้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อย่างต่อเนื่องทุกปี

ในระดับพื้นที่หลายจังหวัดได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายชุมชน มีบทบาทสำคัญในการติดตามเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน การค้นหาเด็กตกหล่น และการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เมื่อเกิดการระบาดของโรคหัด

หรือพบผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มีการดำเนินการให้วัคซีนตอบโต้การระบาด (Outbreak response immunization) อย่างทันท่วงที เพื่อปิดช่องว่างของภูมิคุ้มกันและจำกัดวงการแพร่เชื้อ

ด้านการเตรียมความพร้อม ประเทศไทยได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ให้มีความเพียงพอและพร้อมกระจายสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว รองรับทั้งการให้บริการตามแผนงานปกติ การรณรงค์เป็นกรณีพิเศษ และการตอบโต้การระบาด รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางด้านวัคซีนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและสถานการณ์โรคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดช่องว่างของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสนับสนุนเป้าหมายการกำจัดโรคหัดในระดับประเทศอย่างยั่งยืน

โดยสรุป คือ แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เข้มแข็ง และมีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน อย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล รวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ประชากรย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติ ประชากรแฝง และผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพตามปกติ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการตกหล่นของการให้วัคซีนตามช่วงอายุ การขาดการติดตามเด็กและประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงแนวโน้มความลังเลในการรับวัคซีนในบางกลุ่มประชากร ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างของภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง

2. **ด้านการเฝ้าระวังและระบบเฝ้าระวัง**

   ประเด็นปัญหาและความท้าทาย : ข้อจำกัดของระบบเฝ้าระวังโรคและข้อมูลทางระบาดวิทยา (เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังพบว่าประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยพบว่าอัตราการรายงานโรคยังอยู่ในระดับต่ำในหลายจังหวัด ส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยเฉพาะในประเด็นการรายงานผู้ป่วย การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ การสื่อสารภายในองค์กรยังไม่ทั่วถึง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่บางแห่งไม่ทราบแนวทางการเฝ้าระวังโรคฯ ที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อความครบถ้วนของข้อมูลและคุณภาพของระบบเฝ้าระวังในภาพรวม อีกประเด็นสำคัญคือการหมุนเวียนและการเปลี่ยนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทำให้เกิดช่องว่างในการส่งต่อภารกิจ เจ้าหน้าที่ใหม่อาจไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการฝึกอบรมต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและลดทอนประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง ขณะเดียวกัน การเกิดการระบาดของโรคหัดในบางช่วงเวลาทำให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น จนไม่สามารถรายงานผู้ป่วยได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของไวรัส ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่รายงาน ส่งผลให้การระบุสายพันธุ์ แหล่งที่มา

หรือทิศทางของการแพร่ระบาดในประเทศยังไม่ชัดเจน รวมถึงการมีส่วนร่วมของสถานพยาบาลภาคเอกชนในการรายงานและเฝ้าระวังโรคยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดช่องว่างของข้อมูลในระบบ

นอกจากนี้การประสานข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรคกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดนมีความสำคัญ ข้อมูลที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเดินทางข้ามแดนมารักษาในประเทศไทยเป็นระยะ สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังโรคบริเวณชายแดนรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์และการตรวจจับการระบาด และการควบคุมโรคที่ทันท่วงที

การดำเนินงานของประเทศไทย

จากข้อตกลงร่วมของนานาประเทศในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 (World Health Assembly: WHA) เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้เร่งรัดการกำจัดโรคหัดในระดับโลก ประเทศไทยในฐานะหนึ่งใน 10 ประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ได้ร่วมดำเนินการตามพันธสัญญานานาชาติดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอและโรคหัด ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคหัดในประเทศไทยให้เข้าสู่ระดับที่สามารถกำจัดได้อย่างยั่งยืน ในการดำเนินงานดังกล่าว ประเทศไทยได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคหัดผ่านฐานข้อมูลการกำจัดโรคหัด (Measles Elimination: ME) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้สามารถติดตาม รายงาน และยืนยันผู้ป่วยโรคหัดตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ระบบดังกล่าวกำหนดให้มีการรายงานผู้ป่วยพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและสนับสนุนข้อมูลเชิงระบาดวิทยาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในระยะต่อมา กองระบาดวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและตอบสนองต่อสถานการณ์โรคที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งได้ขยายขอบเขตของระบบให้ครอบคลุมถึงการรายงานผู้ป่วยโรคหัดเยอรมันและหัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome: CRS) เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนป้องกันควบคุมโรค และตอบสนองต่อการระบาดได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้พัฒนาแนวทางการรายงานผู้ป่วยและเกณฑ์การเฝ้าระวังให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ และเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการอัพเดต โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงานและกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ขณะเดียวกันได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรคในทุกระดับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ระบบเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ชัดเจน ทั้งในด้านความครอบคลุมของข้อมูล ความรวดเร็วในการรายงาน และความสามารถในการตรวจจับการระบาด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายบางประการ เช่น ความไวของระบบเฝ้าระวัง การเสริมศักยภาพบุคลากร การเพิ่มอัตราของการรายงานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาอันใกล้

สรุปได้ว่า ระบบเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านความไวและความครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยสงสัยในบางพื้นที่ การรายงานล่าช้า หรือการรายงานไม่ครบถ้วนของข้อมูลสำคัญทางระบาดวิทยา ส่งผลให้การตรวจจับการระบาดในระยะเริ่มต้นยังมีข้อจำกัด นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบเฝ้าระวังโรค ระบบข้อมูลวัคซีน และข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่เป็นเอกภาพ ทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสอบสวนโรคและการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

3. **ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ**

   ประเด็นปัญหาและความท้าทาย : ศักยภาพและความครอบคลุมของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ (เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)

ระบบห้องปฏิบัติการบางประเทศยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากร ห้องปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการรับมือเพื่อตอบโต้การระบาด หลายประเทศยังขาดแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในช่วงการระบาด และการประสานข้อมูลการเฝ้าระวังและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการยังคงเป็นปัญหาในบางประเทศ สำหรับประเทศไทย พบปัญหาและอุปสรรค ชุดน้ำยาทดสอบในการตรวจหาเชื้อไวรัสหัดไม่เพียงพอ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2567 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคหัดพบผู้ป่วยจำนวนมาก แก้ไขปัญหาด้วยการขอรับการสนับสนุนชุดน้ำยาทดสอบที่ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสหัดจากองค์การอนามัยโลก และกำหนดเกณฑ์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสหัดกรณีพิเศษในกรณีเกิดการระบาด

การดำเนินงานของประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมันในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ขององค์การอนามัยโลก มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันในด้านการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ทั้งการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน และการตรวจหาสารพันธุกรรม และการตรวจหาคุณลักษณะของเชื้อระดับสายพันธุ์ (genotype) ของไวรัสหัดและหัดเยอรมัน เพื่อให้การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อโครงการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันโรคหัดและหัดเยอรมันด้วยเทคนิค ELISA ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้ขยายห้องปฏิบัติการการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสหัดและหัดเยอรมันด้วยเทคนิค RT-PCR ในทุกภูมิภาคของประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย ขอนแก่น สมุทรสงคราม และสงขลา

ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ครบทั้ง 14 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในปัจจุบัน โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถส่งตรวจตัวอย่างน้ำเหลือง (serum/plasma) เพื่อตรวจยืนยันโรคหัดและหัดเยอรมัน (Anti-Measles and Rubella IgM) และตัวอย่างสวอป (throat swab / nasal swab) เพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์เชื้อก่อโรคได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2563 ได้เริ่มให้บริการตรวจยืนยันโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด (congenital rubella syndrome : CRS) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจยืนยันโรคหัด และหัดเยอรมันได้ แต่ในบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาความล่าช้าในการเก็บและขนส่งตัวอย่างตรวจ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ชายแดน รวมถึงข้อจำกัดด้านบุคลากร เครื่องมือ และทรัพยากร นอกจากนี้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการที่นอกเหนือเครือข่ายขององค์การอนามัยโลกให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และการพัฒนาศักยภาพการตรวจหาสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสหัดและหัดเยอรมันเพื่อการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการกำจัดโรคในระยะยาว

4. **ด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้การระบาด**
   ประเด็นปัญหาและความท้าทาย : ความพร้อมในการรับมือและตอบโต้การระบาดของโรค (เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)

องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ได้มีการประเมินความพร้อมและการตอบโต้การระบาดในบางประเทศที่ถูกคัดเลือก บางประเทศไม่มีแผนความพร้อมและการตอบสนองการระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโต้ต่อการระบาดในประเทศสมาชิก และพบว่าหลายครั้งที่ทีมตอบโต้การระบาดของบางประเทศ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง เพื่อทำการตรวจหาสารพันธุกรรมและวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ข้อบกพร่องดังกล่าว ทำให้ประสิทธิภาพของ ระบบเฝ้าระวังเสียโอกาสในการระบุแหล่งที่มาของเชื้อที่ก่อให้เกิดการระบาด และการสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระดับสายพันธุ์ของไวรัส ของการระบาดในอนาคต การวิเคราะห์สาเหตุหลักไม่ได้ดำเนินการในการระบาดทุกครั้ง การตอบโต้ต่อการระบาดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การกระจายและการให้วิตามินเอ การติดตามผู้สัมผัสและการค้นหาผู้ป่วยอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามปกติ และระบบสุขภาพเพื่อป้องกันการระบาดในอนาคตยังคงมีความหลากหลาย และไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีทีมตอบโต้การระบาดที่รวดเร็ว เพื่อตอบโต้ต่อการระบาดได้ทันต่อสถานการณ์

การดำเนินงานของประเทศไทย

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้การระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำและปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมและการตอบโต้การระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน ให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและบริบทของประเทศ ให้สามารถตอบสนองต่อการระบาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการตอบโต้การระบาด ประเทศไทยมีทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศ เขต จังหวัด และอำเภอ โดยมีการดำเนินงานสอบสวนควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการตรวจหาสารพันธุกรรมและสายพันธุ์ของเชื้อ เพื่อใช้ในการระบุแหล่งที่มาของเชื้อที่ก่อให้เกิดการระบาด การติดตามที่มาและเส้นทางการแพร่ระบาดของเชื้อ และการเชื่อมโยงข้อมูลทางพันธุกรรมกับการระบาดทั้งในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุการระบาด เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เช่น การให้วัคซีนเสริมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เสี่ยง การให้วิตามินเอในผู้ป่วยตามแนวทางมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรค และตอบโต้การระบาด รวมถึงศักยภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมีความยั่งยืน

โดยสรุป คือ การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้การระบาดของโรคหัด และหัดเยอรมัน ในบางพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านแผนปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การควบคุมการระบาดอาจไม่ทันท่วงทีในบางสถานการณ์ อีกทั้ง การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะยังต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำบทเรียนจากเหตุการณ์การระบาดที่ผ่านมา มาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและการซักซ้อมแผนรับมืออย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านการสนับสนุนและความร่วมมือ

ประเด็นปัญหาและความท้าทาย : นโยบาย การบริหารจัดการ และความยั่งยืนของการดำเนินงาน (เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)

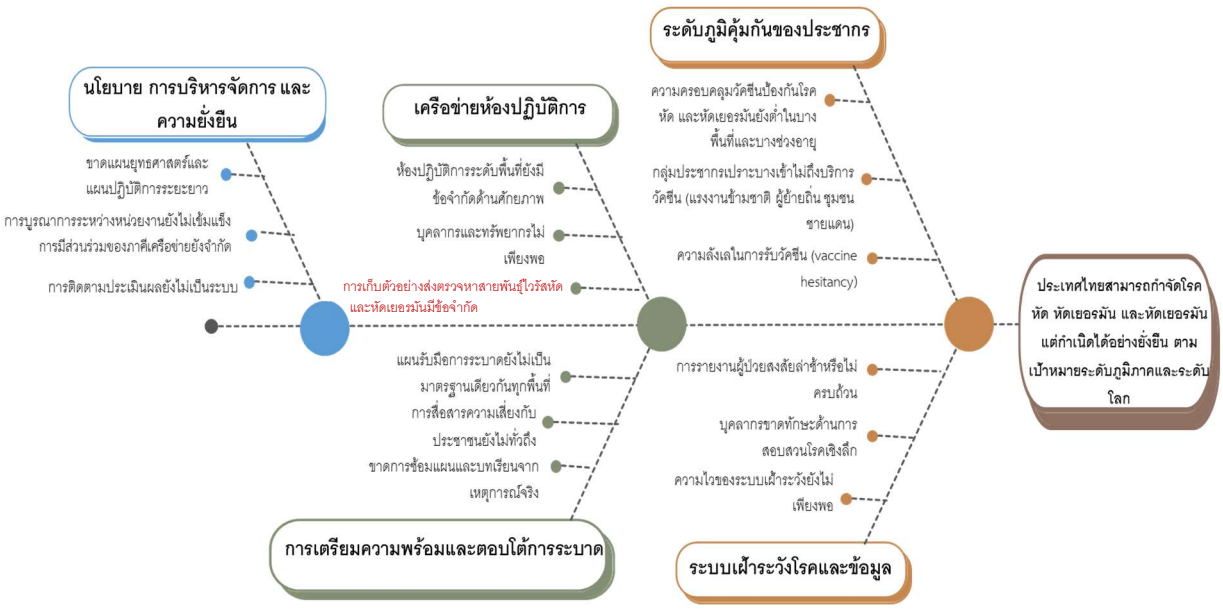
หลายประเทศยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ระดับชาติและ/หรือระดับรองลงมา แม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะนำการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันระดับชาติแล้วก็ตาม ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่เพียงพอ ขาดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการฉีดวัคซีนในทุกภาคส่วน ยังไม่มีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เพื่อการแก้ไขปัญหา บางประเทศความร่วมมือหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไม่สอดคล้องกันและไม่เป็นเอกภาพ ความเข้มแข็งในการประสานงานและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสมาคมการแพทย์แตกต่างกัน

ไปในแต่ละประเทศ การประสานงานระหว่างประเทศยังมีน้อย ข้อมูลต้องผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการในระดับชาติ และมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในภูมิภาคอื่นขององค์การอนามัยโลก

การดำเนินงานของประเทศไทย

ประเทศไทย ได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย ปี 2020 – 2024 โดยบูรณาการเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบาย วิชาการ และการให้บริการวัคซีน มีการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อวัคซีน รวมถึง มีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและประเทศเพื่อนบ้านในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเฝ้าระวัง และการตอบโต้การระบาดข้ามพรมแดน ผ่านกลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการกำจัดโรคในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

สรุปได้ว่า การขับเคลื่อนการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจน การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงพบความท้าทายด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณในระยะยาว และระบบติดตามประเมินผลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการกำจัดโรคอย่างเป็นรูปธรรม การเสริมสร้างกลไกกำกับ ติดตาม และประเมินผล รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



จากการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ และความท้าทายในการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดของประเทศไทยดังที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานในปัจจุบัน ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดเชิงระบบในหลายมิติ ทั้งด้านระดับภูมิคุ้มกันของประชากรที่ยังไม่เพียงพอและไม่สม่ำเสมอ ระบบเฝ้าระวังโรคและข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ศักยภาพและความครอบคลุมของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ความพร้อมในการรับมือและตอบโต้การระบาดของโรค รวมถึงประเด็นด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และความยั่งยืนของการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญและความท้าทายดังกล่าว เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลโดยตรงต่อความสามารถของประเทศในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ตามพันธสัญญานานาชาติ ดังนั้น ประเทศไทย จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดประเทศไทย พ.ศ. 2569 – 2572 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ปิดช่องว่างการดำเนินงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขในทุกระดับ

โดยได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ไว้ 5 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในทุกกลุ่มประชากร ให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรค และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมรับมือและการตอบโต้การระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน อย่างยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จะถูกถ่ายทอดไปสู่มาตรการ แผนปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และสามารถนำไปปรับใช้ในระดับชาติ ระดับเขตสุขภาพ และระดับพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และบรรลุผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บทที่ 4: วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดประเทศไทย ปี พ.ศ. 2569 - 2572

วิสัยทัศน์

ประเทศไทย มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด ตามพันธสัญญานานาชาติ

พันธกิจ

ยกระดับภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังและสอบสวนโรคเข้มแข็ง ห้องปฏิบัติการมาตรฐานครอบคลุม

คำอธิบายความหมายพันธกิจ

1. ยกระดับภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเร่งเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในประชากรเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์

2. เฝ้าระวังและสอบสวนโรคเข้มแข็ง หมายถึง การพัฒนาและขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง การสอบสวนและควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็งทันสมัย สามารถตรวจจับและตอบโต้การระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ห้องปฏิบัติการมาตรฐานครอบคลุม หมายถึง การขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มการเข้าถึงและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันครบตามเกณฑ์อายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ

	พ.ศ.2567	**พ.ศ.2568**	**พ.ศ.2569**	**พ.ศ.2570**	**พ.ศ.2571**	**พ.ศ.2572**
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR 1 (ร้อยละ)	86.6	88	95	95	95	95
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR 2 (ร้อยละ)	85.4	88	95	95	95	95

ตัวชี้วัด 2 ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด สายพันธุ์ท้องถิ่น ภายในประเทศ

	พ.ศ. 2567	**พ.ศ. 2568**	**พ.ศ. 2569**	**พ.ศ. 2570**	**พ.ศ. 2571**	**พ.ศ. 2572**
จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสหัด	5,423 (Lab confirm 4,397 Epi link 1,026)	585 (Lab confirm 503 Epi link 82)*	60	0	0	0
จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน	9	5	0	0	0	0
จำนวนผู้ติดเชื้อหัดเยอรมันแต่กำเนิด	1	0	0	0	0	0

*ข้อมูลจากระบบกำจัดกวาดล้างโรค ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในทุกกลุ่มประชากรให้เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาด

ประเทศไทยยังคงมีช่องว่างทางภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยเฉพาะในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น พื้นที่ชายแดน แรงงานข้ามชาติ และชุมชนที่เข้าถึงบริการสุขภาพได้ยาก ข้อมูลล่าสุดสะท้อนว่าความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ในหลายจังหวัดยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และมีความสัมพันธ์กับการเกิดการระบาดซ้ำในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนจำเป็นต้องได้รับความสำคัญอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เมื่อพิจารณาตามกรอบยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก แนะนำให้ประเทศสมาชิกเร่งเสริมสร้างการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นทั้งในเด็กและกลุ่มวัยอื่น ๆ สนับสนุนการให้วัคซีนตลอดช่วงชีวิต รวมถึงการฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับผู้ใหญ่และกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ พร้อมกับพัฒนาระบบจัดหาวัคซีนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อปิดช่องว่างภูมิคุ้มกันและนำไปสู่การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการป้องกันโรคอย่างยั่งยืน
2. ลดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มประชากรและพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดการระบาด

ตัวชี้วัด

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ครบตามเกณฑ์อายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอทุกพื้นที่ เพื่อทราบช่องว่างภูมิคุ้มกันและเร่งรัดให้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเปราะบางและพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ชายแดน พื้นที่ความไม่สงบ โดยจัดรูปแบบการให้บริการวัคซีนอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการรณรงค์วัคซีนด้วยการวางแผนเชิงรุก และปรับวิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงจูงใจแก่ผู้ปกครอง ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมรณรงค์ที่เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างการยอมรับและเพิ่มความต้องการรับวัคซีน

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลการได้รับวัคซีนที่สามารถเชื่อมโยงให้ครอบคลุมสถานพยาบาลที่ให้บริการวัคซีนทั้งภาครัฐ และเอกชน

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการวัคซีนและการสื่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการจัดสรรและสนับสนุนวัคซีนให้เพียงพอ ทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในการสร้างภูมิคุ้มกันของประชากร

กลยุทธ์ที่ 9 ผลักดันให้มีการจัดหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนวัคซีนให้กับประชากรที่ไม่มีสิทธิประโยชน์ เช่น ประชากรต่างด้าว ผู้ลี้ภัย เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรค และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

ระบบเฝ้าระวังโรคมีความสำคัญในการตรวจจับ และยืนยันการระบาด รวมถึงการค้นหาผู้ป่วยโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก จะช่วยให้สามารถค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกแห่งในประเทศ และสามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีระบบเฝ้าระวังโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดอย่างเป็นทางการ จึงควรผลักดันให้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังดังกล่าว เพื่อประเมินขนาดของปัญหาโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดของประเทศ ได้อย่างชัดเจน ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการตรวจยืนยันเพิ่มเติมเพื่อนำผลการทดสอบมาช่วยในการจำแนก ผู้ป่วยหัด และหัดเยอรมัน ในกรณีที่การตรวจวิธีมาตรฐานทาง Serology และ Molecular ไม่สามารถสรุปการจัดจำแนกผู้ป่วยได้ (case classification)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมัน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดในประเทศไทย ให้มีความไว และมีความครอบคลุมในการตรวจจับโรค
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ด้านมาตรฐาน บุคลากร เครื่องมือ และกระบวนการ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดในประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง และด้านห้องปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน
5. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด ให้มีประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของจังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นที่ไม่ใช่หัดหรือหัดเยอรมัน ไม่น้อยกว่า 2 รายต่อประชากรแสนคนต่อปี (ในระดับประเทศและระดับจังหวัด) ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

2. ร้อยละของผลการเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมัน เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ผู้ป่วยโรคหัดและหัดเยอรมัน ที่ได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 ขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังไข้ออกผื่นให้มีความไว และครอบคลุมสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด และเอกชน

กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมัน ในทุกมิติ

กลยุทธ์ 3 เร่งรัดคุณภาพและความครอบคลุมของระบบเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมัน ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

กลยุทธ์ 4 ยกระดับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ผลักดันให้มีการสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งการขนส่ง ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้แก่สถานพยาบาล ในเครือข่ายเฝ้าระวังและขยายขีดความสามารถในการตรวจสายพันธุ์ (genotyping) เพื่อสนับสนุนการยืนยันการกำจัดโรค

กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังโรคแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจจับและตอบสนองต่อการระบาดได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ 6 พัฒนากลไกการกำกับติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมันอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมนโยบายเร่งรัดการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อและกลไกที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ 8 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง และด้านห้องปฏิบัติการ

กลยุทธ์ 9 พัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและระบบแจ้งเตือนการระบาด เพื่อเพิ่มการตรวจจับผู้ป่วยและเหตุการณ์ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคหัด หัดเยอรมันและหัดเยอรมันแต่กำเนิด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก ตั้งอยู่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัด และหัดเยอรมันของภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (Measles and Rubella Regional Reference Laboratory in South-East Asia Region) มีหน้าที่รับตรวจยืนยันผลการตรวจของห้องปฏิบัติการเครือข่ายในประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการอ้างอิงฯ ยังได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมันที่แพร่ระบาดในประเทศสมาชิกเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อ้างอิงที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ในปี พ.ศ. 2571 การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญ ในการตรวจยืนยันโรคในช่วงการระบาดซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคไข้ออกผื่นที่สงสัยโรคหัดและหัดเยอรมัน เพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริง มีผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การสอบสวน และควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ (Genotype) ของไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ในแต่ละเหตุการณ์ของการระบาด เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของสายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมันที่เป็นสาเหตุของการระบาดในพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจหัดและหัดเยอรมัน (Sub-National Laboratory) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งทุกแห่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก โดยทุกแห่งสามารถตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมันด้วยเทคนิค ELISA และมี 4 แห่งที่สามารถตรวจยืนยันการติดเชื้อได้ด้วยเทคนิค Molecular การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจยืนยันเชื้อ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคหัดและหัดเยอรมันของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครือข่าย ในการตรวจยืนยันโรคหัด และหัดเยอรมัน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันโรคหัดและหัดเยอรมัน เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถบริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับบริการสุขภาพ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ ให้สามารถรองรับการตรวจยืนยันผู้ป่วยทุกรายที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังได้อย่างครบถ้วน และทันเวลา
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ และยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและมาตรฐานองค์การอนามัยโลกครบทุกแห่ง
2. เครือข่ายห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจยืนยันเชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมันต่างสังกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (ISO 15189 หรือ WHO accreditation) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง
3. ร้อยละของการรายงานผลการตรวจยืนยันเชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมันภายใน 2 วัน หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. การรายงานผลการตรวจหาสายพันธุ์เชื้อไวรัสหัดและหัดเยอรมันภายใน 30 วัน หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันโรคหัดและหัดเยอรมันทุกแห่งได้รับการตรวจรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 2 พัฒนาและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจยืนยัน โรคหัดและหัดเยอรมัน นอกสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลยุทธ์ 3 ผลักดันให้มีการสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยันโรคหัด หัดเยอรมันและหัดเยอรมันแต่กำเนิด ภายใต้สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพ

กลยุทธ์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรทบทวนฟื้นฟูองค์ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ

กลยุทธ์ 5 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากร

กลยุทธ์ 6 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจยืนยันและการวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อ

กลยุทธ์ 7 สร้างความร่วมมือระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเตรียมความพร้อมรับมือและการตอบโต้การระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมัน

การเตรียมความพร้อมรับมือและตอบโต้การระบาดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญในการจำกัดการแพร่กระจายของโรคหัดและหัดเยอรมัน โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีพื้นที่ชายแดนยาว มีการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพรมแดนสูง ทีมสอบสวนและควบคุมโรคที่พร้อมปฏิบัติ การบริหารจัดการวัคซีนและทรัพยากร ระบบสนับสนุนที่พร้อม รวมถึงการประสานความร่วมมือข้ามพรมแดน จะช่วยให้สามารถตอบโต้ต่อการระบาดได้อย่างทันท่วงที และป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสามารถตรวจจับ แจ้งเตือน สอบสวนและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และมีมาตรฐาน
2. เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมันในวงกว้าง
3. เพื่อบริหารจัดการวัคซีนสำหรับควบคุมโรคหัดและหัดเยอรมันในกรณีเกิดการระบาด อย่างทันท่วงที

ตัวชี้วัด

1. สามารถตรวจจับการระบาดหลังจากผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการในประเทศไทยได้ภายใน 7 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการระบาดทั้งหมด
2. สามารถแจ้งเตือนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากตรวจจับการระบาดได้ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการระบาดทั้งหมด
3. การระบาดของโรคหัดและหัดเยอรมันได้รับการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งการระบาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการระบาดทั้งหมด
4. สนับสนุนวัคซีนเพื่อป้องการการระบาด ภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งจากพื้นที่

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 บูรณาการระบบเฝ้าระวังโรคและระบบการแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคหัดและหัดเยอรมัน

กลยุทธ์ 2 จัดทำและทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกระดับกรณีเกิดการระบาดโรคหัด และหัดเยอรมัน พร้อมเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการซักซ้อมแผน

กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการสอบสวนและควบคุมโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย และการสนับสนุนวัคซีน กรณีเกิดการระบาดของ โรคหัดและหัดเยอรมัน

กลยุทธ์ 4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคหัด และหัดเยอรมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 5 เสริมสร้างการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคให้กับประชาชน

กลยุทธ์ 6 ติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนเหตุการณ์การระบาดของโรคหัด และหัดเยอรมัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: นโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน อย่างยั่งยืน

การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการผลักดันเชิงนโยบาย และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และระบบบริหารจัดการอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความมั่นคงของระบบบริหารจัดการวัคซีนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำจัดโรค และการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชน รวมทั้งจัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวและครบถ้วนตามนโยบายที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีนโยบายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้สามารถขับเคลื่อนการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อให้มีการสนับสนุนทรัพยากรการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเพียงพอ มีความคล่องตัว และต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ทุกจังหวัดมีการดำเนินงาน กิจกรรม มาตรการ เพื่อการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 ผลักดันให้กรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิดประเทศไทย พ.ศ. 2569 – 2572 ของประเทศไทยได้รับการ สนับสนุนเชิงนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติงานระดับพื้นที่

กลยุทธ์ 2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัดและหัดเยอรมัน และตระหนักถึงการเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

กลยุทธ์ 3 บริหารจัดการวัคซีนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งวัคซีนสำหรับภาวะปกติ การรณรงค์ และการตอบโต้การระบาด

กลยุทธ์ 4 พัฒนากลไกการกำกับดูแล ระบบติดตามประเมินผล และการประสานงานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

กลยุทธ์ 5 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน

กลยุทธ์ 6 พัฒนากลไกการวิเคราะห์อุปสรรคและช่องว่างของการเข้าถึงบริการวัคซีนและมาตรการกำจัดโรค

บทที่ 5: การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2569 – 2572 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้

ด้านการเตรียมการ

1. คณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ตามพันธสัญญานานาชาติ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม มาตรการที่กำหนด

2. ชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนฯ ไปยังหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางและมีเป้าหมายไปในทางเดียวกัน

3. สนับสนุนให้หน่วยงานระดับจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยใช้กรอบยุทธศาสตร์ด้านการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด พ.ศ. 2569 - 2572 เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

1. ผลักดันตัวชี้วัดการกำจัดโรคหัดและโรคหัดเยอรมันของประเทศไทย เข้าในแผนงานและระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดของหน่วยงาน

2. ขอความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด โดยการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- กระทรวงสาธารณสุข
    - กรมควบคุมโรค
        - กองโรคติดต่อทั่วไป
        - กองระบาดวิทยา
        - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
        - สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
    - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
        - ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
        - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ
    - กรมอนามัย
    - กรมการแพทย์
    - สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        - กองตรวจราชการ

- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 13
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- โรงพยาบาลศูนย์
- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลชุมชน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- องค์การเภสัชกรรม
- กรุงเทพมหานคร
  - สำนักอนามัย
  - สำนักการแพทย์
  - โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
  - ศูนย์บริการสาธารณสุข
- สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
- สถานพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สถานพยาบาลภาคเอกชน
- องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
- องค์การยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund: UNICEF)

ด้านการประเมินผล

1. คณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและการกำจัดโรคหัด หัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

2. สรุปรายงานความก้าวหน้าและเสนอให้คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติ ทราบเป็นระยะ

บรรณานุกรม

1. World Health Organization South-East Asia Regional Office. Strategic plan for measles and rubella elimination in WHO South-East Asia Region: 2024 - 2028. Printed in India; 2024.
2. แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย ปี 2020 – 2024.
3. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค พริ้นติ้ง จำกัด; 2562.
4. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567
5. National Verification Committee. Annual Country Report on Progress toward Measles Elimination and Rubella/CRS Control YEAR 2024.

ภาคผนวก

คำสั่งคณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ตามพันธสัญญานานาชาติ



คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ ๑๔๖๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ตามพันธสัญญานานาชาติ

อนุสนธิคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้รับผิดชอบงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเร่งรัดมาตรการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัด และหัดเยอรมันเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างครอบคลุมและสามารถเฝ้าระวังสถานการณ์โรคตลอดจนการรายงานผลการตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมควบคุมโรค จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ

๒. แต่งตั้งคณะทำงานประสานข้อมูลการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

๒.๑.๑	นางสาวจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค	ที่ปรึกษา
๒.๑.๒	นายสมชาย พีระปกรณ์ พนักงานบำนาญขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย	ประธานคณะทำงาน
๒.๑.๓	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค	รองประธานคณะทำงาน
๒.๑.๔	ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	รองประธานคณะทำงาน
๒.๑.๕	นายชนินันท์ สนธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข	คณะทำงาน

๒.๑.๖	นางสาวสุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะทำงาน
๒.๑.๗	หัวหน้าฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน
๒.๑.๘	หัวหน้าฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน
๒.๑.๙	นางสาวนภา อ่อนวิมล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน
๒.๑.๑๐	นายประสพชัย อร่ามรุ่งโรจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน
๒.๑.๑๑	นางสาวกรรณิการ์ ชวัญชุม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะทำงาน
๒.๑.๑๒	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๑.๑๓	นายธนพล ยิสารคุณ นายแพทย์ชำนาญการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๑.๑๔	นางสาวปรางณพิชญ์ วิหารหอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๑.๑๕	นางสาวปณิตา คุ้มผล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๑.๑๖	นายฤทธิชัย ใจผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๑.๑๗	หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๑.๑๘	นางมนัญญา ประเสริฐสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน

๒.๑.๑๙ นางสาว...

๒.๑.๑๙ นางสาวจิราวรรณ เวหุวนารักษ์ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๐ นายวิรัตน์ พลเสิศ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๑ ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง คณะทำงาน
การกำจัดโรคหัด หัดเยอรมันและการกวาดล้างโรคโปลิโอ และเลขานุการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๒ ผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งการกำจัด คณะทำงาน
โรคหัด หัดเยอรมันและการกวาดล้างโรคโปลิโอ และเลขานุการร่วม
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๓ นางสาวศริญญา ไชยยา คณะทำงาน
ผู้ประสานงานโครงการและการเงินโครงการ และเลขานุการร่วม
กำจัดโรคหัด หัดเยอรมันและหัดเยอรมันแต่กำเนิด
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๔ นายฉัตรมงคล สัมแป้น คณะทำงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และเลขานุการร่วม
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๕ นายภูมิภัทร ยอดชมภู คณะทำงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และผู้ช่วยเลขานุการ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๖ นางสาวปุณยาพร นนท์มุติ คณะทำงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล และผู้ช่วยเลขานุการ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

๒.๑.๒๗ เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการโครงการสร้างเสริม คณะทำงาน
ความเข้มแข็งการกำจัดโรคหัดหัดเยอรมัน และผู้ช่วยเลขานุการ
และการกวาดล้างโรคโปลิโอ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

๒.๒.๑ รวบรวม ตรวจสอบ และบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ ในด้านระบาดวิทยา การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

๒.๒.๒ จัดเตรียม...

๒.๒.๒ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ

๒.๒๓ จัดทำข้อเสนอแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติงาน ให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อการดำเนินการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ

๒.๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๑๐๓๙/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติ

ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติ ไปแล้ว นั้น

ประเทศไทยมีการดำเนินงานกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันมาอย่างต่อเนื่อง และพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมัน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก จึงจำเป็นต้องปรับองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และเพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานตามมาตรการหลักของการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติ

๒.๑ องค์ประกอบ

๒.๑.๑	นายพงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๒.๑.๒	นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๒.๑.๓	นางสาวจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค	ประธานกรรมการ
๒.๑.๔	รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมาย	กรรมการ
๒.๑.๕	นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กรรมการ
๒.๑.๖	นายศิริศักดิ์ วรินทราวาท ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค	กรรมการ
๒.๑.๗	นายสมชาย พีระปกรณ์ พนักงานบำนาญขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย	กรรมการ

๒.๑.๘ ...

๒.๑.๘	นางกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	กรรมการ
๒.๑.๙	นายประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	กรรมการ
๒.๑.๑๐	นายยงเจือ เหล่าศิริถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	กรรมการ
๒.๑.๑๑	นายปณิธี ธัมมวิจยะ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค	กรรมการ
๒.๑.๑๒	นายเฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน การพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก ๗)	กรรมการ
๒.๑.๑๓	นายชนินันท์ สนธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข	กรรมการ
๒.๑.๑๔	นายวรมันต์ ไวดาบ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	กรรมการ
๒.๑.๑๕	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค	กรรมการ และเลขานุการ
๒.๑.๑๖	ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	กรรมการ และเลขานุการร่วม
๒.๑.๑๗	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรรมการ และเลขานุการร่วม
๒.๑.๑๘	หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๑๙	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๒๐	หัวหน้าฝ่ายไวรัสระบบประสาท และระบบไหลเวียนโลหิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๒๑	หัวหน้าฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๒๒ ...

๒.๑.๒๒ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง การกำจัดโรคหัด หัดเยอรมันและการกวาดล้างโรคโปลิโอ กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค — ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

๒.๒.๑ ให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การเฝ้าระวังโรค และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการกำจัดกวาดล้างโรค

๒.๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการกำจัดกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย

๒.๒.๓ ติดตามประเมินกิจกรรมการกำจัดกวาดล้างโรค เพื่อให้มีกระบวนการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

๒.๒.๔ ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการเสนอรายงานประจำปีของประเทศไทยต่อองค์การอนามัยโลก รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับรองผล

๒.๒.๕ คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโรคโปลิโอ การกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข